

CRO中心选择方案

项目名称：SPOTLIGHT-GC-301

适应症：CLDN18.2阳性、HER2阴性局部晚期不可切除或转移性胃及胃食管结合部腺癌

试验阶段：III期注册性研究

申办方：[申办方名称]

CRO：SMO

文档版本：V1.0

编制日期：2026年1月21日

编制人：临床运营部

目录

- [1. 执行摘要](#)
- [2. 项目背景与中心选择目标](#)
- [3. 中心选择策略](#)
- [4. 多维度评估体系](#)
- [5. 目标中心评估结果](#)
- [6. 入组预测与时间规划](#)
- [7. 竞争格局分析](#)
- [8. 风险评估与缓解措施](#)
- [9. 资源配置计划](#)
- [10. 附录](#)

1. 执行摘要

1.1 项目概述

本方案针对SPOTLIGHT-GC-301项目（评价Zolbetuximab联合mFOLFOX6对比安慰剂联合mFOLFOX6一线治疗CLDN18.2阳性、HER2阴性晚期胃癌的随机、双盲、III期临床研究）的中国区中心选择进行规划。

1.2 中心选择结论

项目	内容
目标入组数	150例（中国区配额）
推荐中心数	3家

项目	内容
预计入组周期	18个月
平均入组速率	2.8例/中心/月

1.3 推荐中心清单

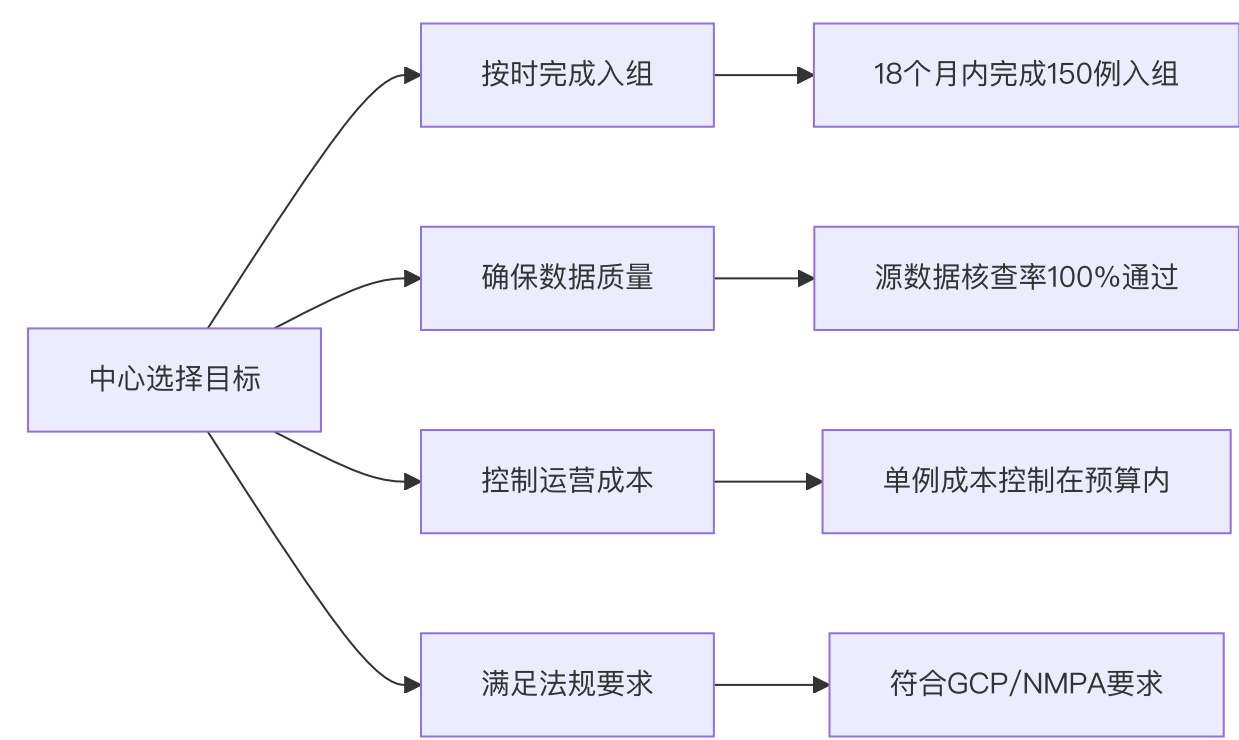
序号	中心名称	所在城市	预计入组数	综合评分
1	复旦大学附属肿瘤医院	上海	60例	92/100
2	浙江省肿瘤医院	杭州	50例	88/100
3	中山大学肿瘤防治中心	广州	40例	85/100

2. 项目背景与中心选择目标

2.1 试验设计要点

设计要素	具体要求
试验类型	多中心、随机、双盲、安慰剂对照、III期
主要终点	总生存期（OS）、无进展生存期（PFS）
目标人群	CLDN18.2阳性（≥75%肿瘤细胞膜染色≥2+）、HER2阴性、一线治疗
随机比例	1:1（试验组 vs 对照组）
分层因素	地区（亚洲 vs 其他）、ECOG评分（0 vs 1）、转移部位数量（≤2 vs >2）

2.2 中心选择核心目标



2.3 理想中心画像（Ideal Site Profile）

基于项目特点，定义以下中心必备条件：

一票否决项（Deal Breakers）

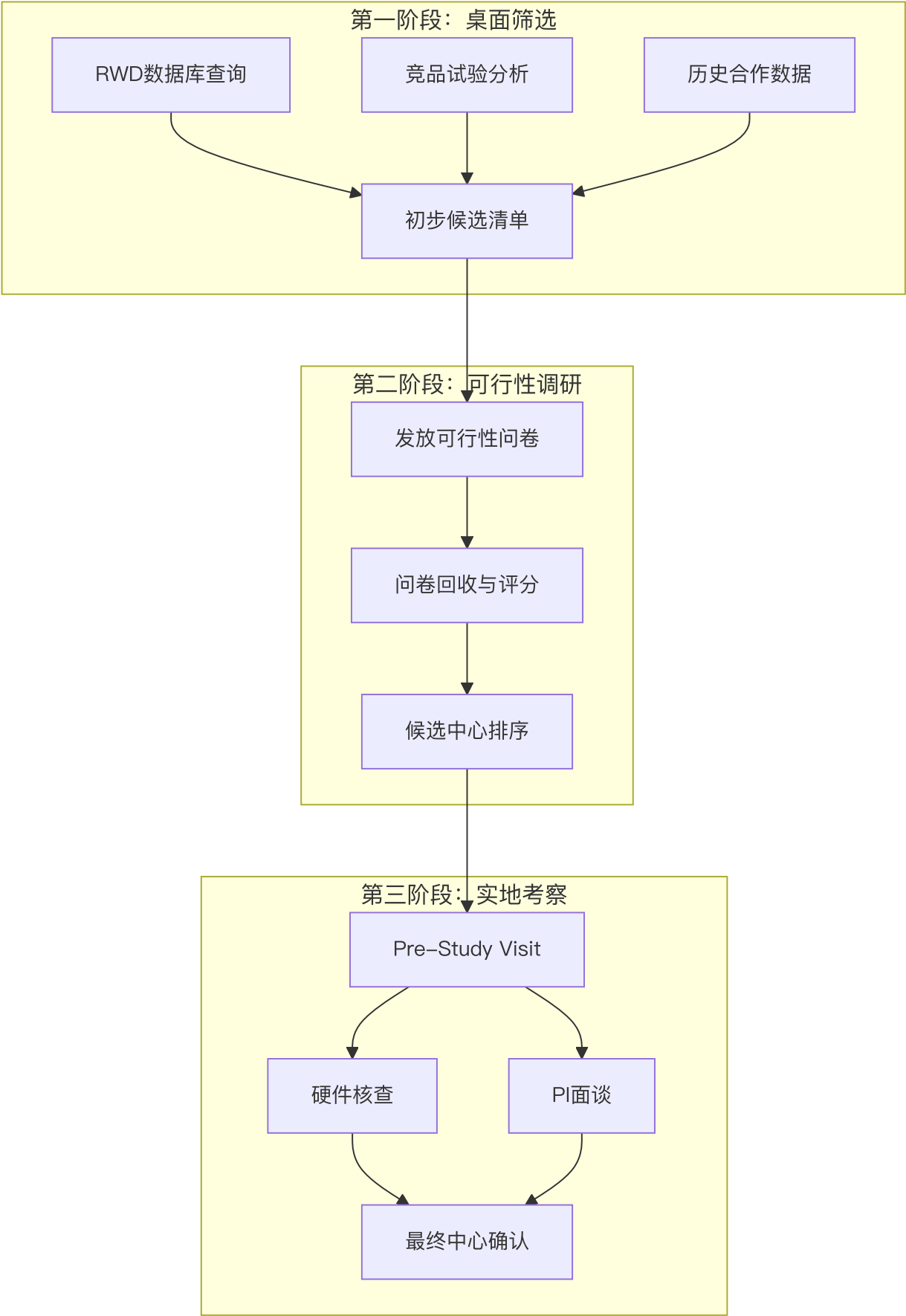
类别	硬性要求
设备	CT层厚≤5mm，满足RECIST 1.1评估要求
冷链	具备-80℃超低温冰箱及温控记录系统
伦理	接受组长单位伦理批件或伦理审查周期≤6周
遗传办	有生物样本外送备案经验
CLDN18.2检测	接受中心实验室复核结果为准

优选条件（Preferred）

- 年胃癌门诊量≥3000例
- PI有同类靶点或免疫联合化疗试验经验
- 允许SMO派遣CRC进驻
- 电子病历系统经过验证，支持远程监查

3. 中心选择策略

3.1 策略框架



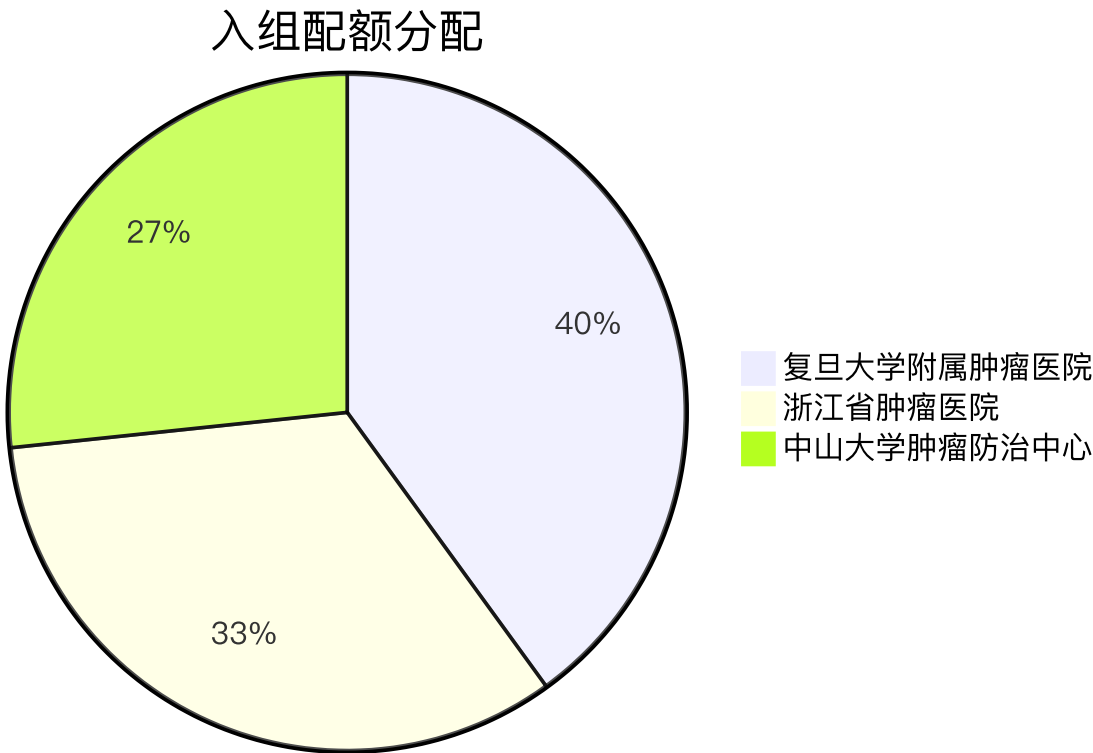
3.2 地理分布策略

考虑胃癌在中国的流行病学特征（高发于东部沿海及华南地区），本项目采用**华东-华南双核心布局**：

区域	目标中心	战略定位
华东	复旦大学附属肿瘤医院、浙江省肿瘤医院	主力入组区，覆盖长三角患者人群
华南	中山大学肿瘤防治中心	辐射珠三角及华南区域

3.3 入组分配策略

基于各中心的患者资源、历史绩效及启动速度，采用**差异化配额分配**：



4. 多维度评估体系

4.1 评估维度与权重

维度	权重	评估要点
患者资源与入组潜力	30%	患者池规模、筛选合格率、竞争损耗
研究者与团队能力	25%	PI经验与投入度、CRC配置、既往绩效
启动速度与行政效率	20%	伦理周期、合同流程、遗传办经验
硬件设施与合规性	15%	影像设备、样本处理、急救设施
数据质量与历史表现	10%	源文件管理、稽查历史、数据录入及时性

4.2 详细评分标准

4.2.1 患者资源与入组潜力（30分）

评分项	满分	评分标准
年胃癌门诊/住院量	8分	≥5000例:8分; 3000–5000例:6分; 1000–3000例:4分; <1000例:2分
CLDN18.2+/HER2–患者预估	8分	基于漏斗分析计算, 每10例预估患者得1分, 上限8分
同期竞品试验数量	7分	0个:7分; 1–2个:5分; 3–4个:3分; ≥5个:1分
转诊网络覆盖	7分	有成熟转诊网络:7分; 有初步网络:4分; 无网络:1分

4.2.2 研究者与团队能力 (25分)

评分项	满分	评分标准
PI同类试验经验	8分	有CLDN18.2/胃癌靶向经验:8分; 有其他胃癌III期经验:5分; 仅有I/II期经验:3分
PI投入度评估	6分	专职投入:6分; 兼顾≤3个项目:4分; 兼顾>3个项目:2分
CRC配置模式	6分	允许SMO派驻专职CRC:6分; 医院配备专职CRC:4分; 护士兼职:2分
既往合作记录	5分	优秀(无违规/高配合度):5分; 良好:3分; 有黄牌记录:1分; 黑名单:0分

4.2.3 启动速度与行政效率 (20分)

评分项	满分	评分标准
伦理审查周期	7分	≤4周:7分; 4–6周:5分; 6–8周:3分; >8周:1分
合同签署周期	5分	≤4周:5分; 4–6周:3分; >6周:1分
遗传办备案经验	5分	有成功备案经验:5分; 有提交经验:3分; 无经验:1分
接受中心伦理	3分	接受:3分; 需本院复审:1分; 不接受:0分

4.2.4 硬件设施与合规性 (15分)

评分项	满分	评分标准
CT设备(层厚≤5mm)	5分	完全满足:5分; 需调参:3分; 不满足:0分(否决)
样本处理设施	4分	–80℃冰箱+温控记录:4分; 仅–20℃:2分; 不满足:0分(否决)
急救设施配置	3分	抢救车/除颤仪/吸氧在给药区:3分; 需调配:1分; 不满足:0分
药品储存条件	3分	专用药房+温控监测:3分; 共用但合规:2分; 不满足:0分

4.2.5 数据质量与历史表现 (10分)

评分项	满分	评分标准
电子病历系统	4分	经验证+支持远程查阅:4分; 经验证:2分; 未验证:1分
既往稽查结果	3分	无重大发现:3分; 有观察项:2分; 有缺陷:1分; 有严重违规:0分
数据录入及时性	3分	历史平均≤3天:3分; 3–7天:2分; >7天:1分

5. 目标中心评估结果

5.1 中心一： 复旦大学附属肿瘤医院

基本信息

项目	信息
中心名称	复旦大学附属肿瘤医院
地址	上海市徐汇区东安路270号
等级	三级甲等肿瘤专科医院
拟任PI	李XX教授（胃肠外科主任医师）
Sub-I	张XX副主任医师、王XX主治医师

可行性问卷关键数据

指标	数据
年胃癌门诊量	约8,500例
年胃癌住院手术量	约1,200例
预估CLDN18.2+/HER2-患者	约120例/年（基于15%阳性率）
同期竞品试验	2个（1个CLDN18.2 II期，1个PD-1联合化疗III期）
伦理委员会频率	每2周开会
预计伦理周期	3-4周
CRC配置	允许SMO派驻，医院另配1名专职CRC

硬件核查结果（Pre-Study Visit）

核查项	结果	备注
CT层厚	✔ 满足（3mm可调）	Siemens SOMATOM Definition
-80℃冰箱	✔ 具备	有温控记录仪，校准有效期至2027年
离心机	✔ 已校准	校准证书有效
急救设施	✔ 完备	抢救车、除颤仪在化疗室5米内
药品储存	✔ 专用研究药房	2-8℃冰箱，温控监测完善

评分汇总

维度	得分	满分
患者资源与入组潜力	27	30
研究者与团队能力	23	25
启动速度与行政效率	18	20
硬件设施与合规性	14	15
数据质量与历史表现	10	10
总分	92	100

优势与风险

优势	风险
国内顶级肿瘤中心，胃癌诊疗量全国领先 同期有2个竞品试验，存在患者竞争 PI为胃癌领域KOL，有丰富III期试验经验 PI同时负责多个项目，需关注投入度 伦理效率高，有遗传办备案成功经验 合同流程涉及复旦大学资产管理，可能延长 转诊网络覆盖江浙沪皖	-

5.2 中心二：浙江省肿瘤医院

基本信息

项目	信息
中心名称	浙江省肿瘤医院（中国科学院大学附属肿瘤医院）
地址	浙江省杭州市拱墅区半山街道广济路38号
等级	三级甲等肿瘤专科医院
拟任PI	陈XX教授（腹部肿瘤内科主任）
Sub-I	刘XX副主任医师

可行性问卷关键数据

指标	数据
年胃癌门诊量	约5,200例
年胃癌住院量	约800例
预估CLDN18.2+/HER2-患者	约80例/年
同期竞品试验	1个（HER2 ADC III期，人群不重叠）
伦理委员会频率	每2周开会
预计伦理周期	4周
CRC配置	允许SMO派驻

硬件核查结果（Pre-Study Visit）

核查项	结果	备注
CT层厚	✅ 满足（5mm）	GE Revolution CT
-80℃冰箱	✅ 具备	位于中心实验室，需协调取样流程
离心机	✅ 已校准	-
急救设施	✅ 完备	-
药品储存	✅ 合规	与其他研究共用药房，但有独立储位

评分汇总

维度		得分	满分
患者资源与入组潜力		25	30
研究者与团队能力		22	25
启动速度与行政效率		18	20
硬件设施与合规性		13	15
数据质量与历史表现		10	10
总分		88	100
优势与风险			
优势		风险	
浙江省肿瘤诊疗龙头，患者来源稳定		患者池规模略逊于复旦肿瘤	
PI对CLDN18.2靶点有研究兴趣，动机强		-80℃冰箱位于中心实验室，需优化取样SOP	
同期竞品人群不重叠，竞争压力小		-	
与CRO有良好历史合作记录		-	

5.3 中心三：中山大学肿瘤防治中心

基本信息	
项目	信息
中心名称	中山大学肿瘤防治中心（中山大学附属肿瘤医院）
地址	广东省广州市越秀区东风东路651号
等级	三级甲等肿瘤专科医院
拟任PI	徐XX教授（内科主任医师）
Sub-I	黄XX副主任医师、周XX主治医师
可行性问卷关键数据	
指标	数据
年胃癌门诊量	约4,800例
年胃癌住院量	约700例
预估CLDN18.2+/HER2-患者	约70例/年
同期竞品试验	2个（1个CLDN18.2 I期扩展队列，1个IO联合化疗）
伦理委员会频率	每周开会
预计伦理周期	3周
CRC配置	医院配备专职研究护士，SMO可辅助

硬件核查结果（Pre-Study Visit）

核查项	结果	备注
CT层厚	✔ 满足（3mm）	Philips Brilliance iCT
-80℃冰箱	✔ 具备	位于日间化疗中心，便于取样
离心机	✔ 已校准	-
急救设施	✔ 完备	-
药品储存	✔ 专用研究药房	条件优越

评分汇总

维度	得分	满分
患者资源与入组潜力	23	30
研究者与团队能力	21	25
启动速度与行政效率	19	20
硬件设施与合规性	14	15
数据质量与历史表现	8	10
总分	85	100

优势与风险

优势	风险
华南地区肿瘤治疗权威中心	有同靶点I期扩展队列在进行，需协调患者分流
伦理效率极高（每周开会）	广东地区患者对长期随访依从性需关注
PI团队研究能力强，数据质量有保障	历史数据录入及时性略慢（平均5天）
转诊网络覆盖粤港澳大湾区	-

5.4 中心对比汇总

评估维度	复旦大学附属肿瘤医院	浙江省肿瘤医院	中山大学肿瘤防治中心
患者资源与入组潜力	★★★★★ (27/30)	★★★★★ (25/30)	★★★★★ (23/30)
研究者与团队能力	★★★★★ (23/25)	★★★★★ (22/25)	★★★★★ (21/25)
启动速度与行政效率	★★★★★ (18/20)	★★★★★ (18/20)	★★★★★ (19/20)
硬件设施与合规性	★★★★★ (14/15)	★★★★★ (13/15)	★★★★★ (14/15)
数据质量与历史表现	★★★★★ (10/10)	★★★★★ (10/10)	★★★★★ (8/10)
综合评分	92/100	88/100	85/100
推荐入组配额	60例	50例	40例

6. 入组预测与时间规划

6.1 入组曲线预测

基于各中心可行性数据及历史绩效，采用蒙特卡洛模拟预测入组曲线：

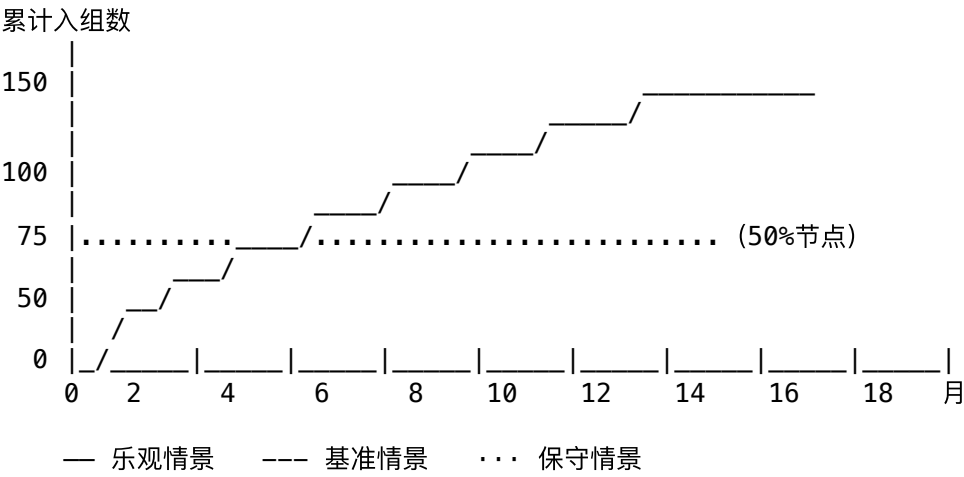
假设参数

中心	月入组速率（乐观）	月入组速率（基准）	月入组速率（保守）
复旦大学附属肿瘤医院	4.0例	3.3例	2.5例
浙江省肿瘤医院	3.5例	2.8例	2.0例
中山大学肿瘤防治中心	3.0例	2.2例	1.5例

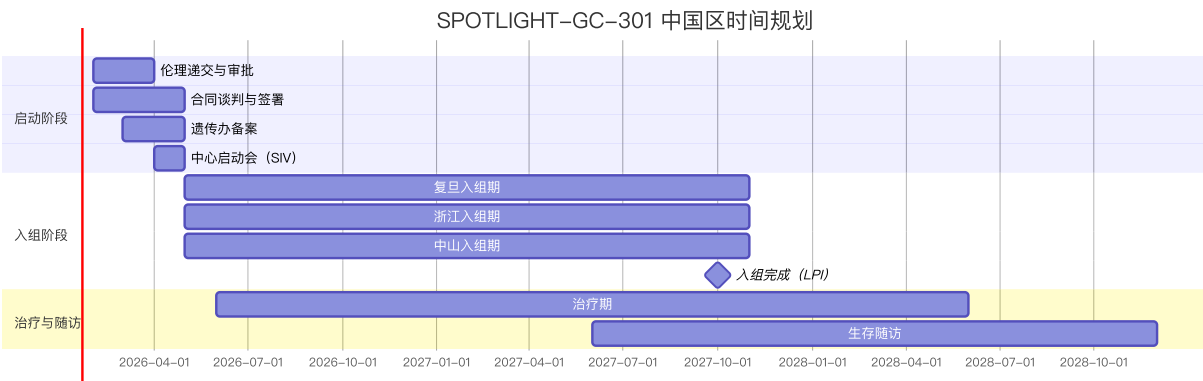
入组里程碑预测

里程碑	乐观情景	基准情景	保守情景
首例入组（FPI）	启动后1个月	启动后1.5个月	启动后2个月
50%入组（75例）	第8个月	第10个月	第13个月
100%入组（150例）	第14个月	第18个月	第24个月

入组曲线图



6.2 项目时间表



6.3 关键里程碑

里程碑	目标日期	责任方
中心选择方案定稿	2026年1月	CRO临床运营
伦理递交（组长单位）	2026年2月	CRO注册事务
伦理批准	2026年3月	-
遗传办备案完成	2026年4月	CRO注册事务
首家中心启动（SIV）	2026年4月	CRO/Sponsor
首例患者入组（FPI）	2026年5月	-
50%入组完成	2027年2月	-
末例患者入组（LPI）	2027年10月	-

7. 竞争格局分析

7.1 同靶点/同适应症在研试验

基于ClinicalTrials.gov及药物临床试验登记与信息公示平台数据：

试验名称	申办方	阶段	靶点	预计入组数	竞争影响
GLOW研究	A公司	III期	CLDN18.2	中国区100例	高
ILUSTRO扩展	B公司	I/II期	CLDN18.2	中国区30例	中
CheckMate XXX	C公司	III期	PD-1	中国区200例	中（人群部分重叠）

7.2 目标中心竞品分布

中心	在研竞品试验	竞争风险	应对策略
复旦大学附属肿瘤医院	GLOW研究、某IO联合化疗研究	中-高	强调差异化入排标准，与PI明确患者分流原则
浙江省肿瘤医院	某HER2 ADC研究（人群不重叠）	低	无需特别应对
中山大学肿瘤防治中心	ILUSTRO扩展队列、某IO研究	中	I期扩展队列入组近尾声，影响有限

7.3 竞争差异化策略

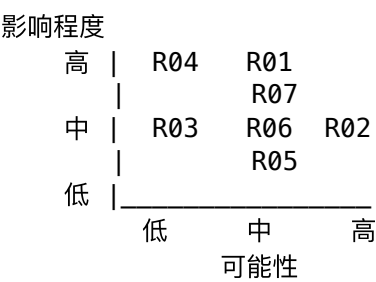
- 入排标准优化：与竞品相比，适度放宽肝功能要求（AST/ALT≤3×ULN），扩大符合条件患者池
- 访视便利性：减少非必要的PK采样点，降低患者负担
- 研究者激励：提供有竞争力的研究者费用及学术支持
- 快速启动：承诺SIV后2周内可接受首例筛选

8. 风险评估与缓解措施

8.1 风险登记册

风险ID	风险描述	可能性	影响	风险等级	缓解措施	责任人
R01	入组速度低于预期	中	高	高	备选中心储备；强化转诊网络；优化筛选流程	临床运营经理
R02	CLDN18.2检测筛选失败率高	中	中	中	优化组织样本采集SOP；与中心实验室建立快速反馈机制	医学监查员
R03	伦理审批延迟	低	中	低	提前准备完整递交材料；与伦理委员会预沟通	注册事务
R04	遗传办备案延误	中	高	高	尽早启动备案流程；备案期间启动其他准备工作	注册事务
R05	PI投入度不足	低	中	低	定期PI沟通会；Sub-I赋能培训	项目经理
R06	竞品试验争夺患者	中	中	中	差异化入排标准；提升中心启动速度	临床运营经理
R07	样本运输冷链断裂	低	高	中	选用专业冷链物流供应商；配备温度记录仪	供应链经理

8.2 风险热力图



8.3 应急预案

入组滞后应急方案

触发条件	应急措施
单中心连续2个月入组<预期50%	PM与PI召开专项会议，分析原因并调整策略
3个月后整体入组进度<预期70%	启动备选中心激活流程（备选：江苏省肿瘤医院、湖南省肿瘤医院）
6个月后整体入组进度<预期60%	申请方案修订，考虑放宽入排标准

9. 资源配置计划

9.1 CRA监查计划

中心	配备CRA	监查频率	预计监查访视次数
复旦大学附属肿瘤医院	1名资深CRA + 1名CRA	每2周1次	约80次（含SIV/COV）
浙江省肿瘤医院	1名资深CRA	每2周1次	约65次
中山大学肿瘤防治中心	1名资深CRA	每2周1次	约55次

9.2 CRC配置计划

中心	CRC来源	配置数量	工作模式
复旦大学附属肿瘤医院	SMO派驻 + 医院CRC	2人	全职驻场
浙江省肿瘤医院	SMO派驻	1人	全职驻场
中山大学肿瘤防治中心	医院研究护士 + SMO辅助	1.5人	医院主导，SMO支持

9.3 预算估算（中心相关）

费用项目	复旦	浙江	中山	合计
中心启动费	¥50,000	¥40,000	¥45,000	¥135,000
伦理审查费	¥8,000	¥6,000	¥7,000	¥21,000
研究者费用（按例）	¥30,000×60	¥28,000×50	¥28,000×40	¥4,020,000
CRA差旅费（预估）	¥120,000	¥80,000	¥100,000	¥300,000
CRC服务费	¥180,000	¥120,000	¥100,000	¥400,000
中心相关小计	¥2,158,000	¥1,646,000	¥1,372,000	¥5,176,000

注：以上为估算值，最终以合同签署为准。

10. 附录

附录A：可行性问卷模板（节选）

A.1 患者资源部分

1. 贵中心过去12个月诊治的胃癌/胃食管结合部腺癌患者数量：_____ 例
2. 其中IV期（局部晚期不可切除或转移性）患者比例：_____ %
3. 预估符合以下标准的患者数量（年）：

○ HER2阴性：_____ 例

○ 一线治疗：_____ 例

○ ECOG 0-1：_____ 例
4. 贵中心目前是否有进行中的胃癌临床试验？如有，请列明：

试验名称 靶点/机制 阶段 目前入组数/目标数**A.2 研究团队部分**

5. 拟任PI信息：

- 姓名/职称：_____
- GCP证书编号：_____
- 过去3年主导的III期试验数量：_____

6. Sub-I数量及职称：_____

7. CRC配置模式：

- 医院专职CRC
- 允许SMO派驻
- 护士兼职

A.3 启动效率部分

8. 伦理委员会开会频率：_____ /月

9. 预计伦理审批周期：_____ 周

10. 是否接受组长单位伦理批件？ [] 是 [] 否

11. 预计合同签署周期：_____ 周

12. 是否有遗传办（HGRAC）备案经验？ [] 是 [] 否

A.4 硬件设施部分

13. CT设备型号及最小层厚：_____

14. 是否具备-80℃超低温冰箱？ [] 是 [] 否，位置：_____

15. 离心机是否在校准有效期内？ [] 是 [] 否

16. 化疗区域5米内是否配备抢救车/除颤仪？ [] 是 [] 否

附录B：Pre-Study Visit核查清单

核查项目	核查内容	结果	备注
影像设备	CT层厚是否≤5mm	☐ 通过 ☐ 不通过	
	影像可否导出DICOM格式	☐ 通过 ☐ 不通过	
样本处理	-80℃冰箱是否可用	☐ 通过 ☐ 不通过	

核查项目	核查内容	结果	备注
	温控记录仪是否配备	☐ 通过 ☐ 不通过	
	离心机校准状态	☐ 通过 ☐ 不通过	
药品储存	2-8℃冰箱是否专用	☐ 通过 ☐ 不通过	
	温控监测系统	☐ 通过 ☐ 不通过	
急救设施	抢救车位置及距离	☐ 通过 ☐ 不通过	距离：__米
	除颤仪可用状态	☐ 通过 ☐ 不通过	
	吸氧设备	☐ 通过 ☐ 不通过	
档案管理	研究档案室是否独立	☐ 通过 ☐ 不通过	
	门禁/防火设施	☐ 通过 ☐ 不通过	

附录C：缩略语表

缩略语	全称	中文
CRA	Clinical Research Associate	临床监查员
CRC	Clinical Research Coordinator	临床研究协调员
CRO	Contract Research Organization	合同研究组织
EC	Ethics Committee	伦理委员会
FPI	First Patient In	首例患者入组
GCP	Good Clinical Practice	药物临床试验质量管理规范
HGRAC	Human Genetic Resources Administration of China	中国人类遗传资源管理办公室
LPI	Last Patient In	末例患者入组
PI	Principal Investigator	主要研究者
PSV	Pre-Study Visit	中心筛选访视
RWD	Real-World Data	真实世界数据
SIV	Site Initiation Visit	中心启动访视
SMO	Site Management Organization	中心管理组织
SOP	Standard Operating Procedure	标准操作规程
Sub-I	Sub-Investigator	次要研究者

附录D：文档版本历史

版本	日期	修订内容	修订人	审批人
V1.0	2026-01-21	初始版本	[编制人]	[审批人]

文档结束

本文档为机密文件，仅供[申办方名称]与[CRO名称]项目团队内部使用。未经授权，不得复制、分发或泄露。